پر کن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تاکہ اہل فن صاحب علم ہماری تحقیقات کو پوری طرح ذہن نشین کر سکیں اور ان کو من بات کا اندازہ ہو سکے۔

ایلوپیتھی کی تحقیقات

نام۔ ایستھما۔ ایزما۔ ASTHMA

تعریف ایستھما یعنی دمہ یہ مرض قصبۃ الریہ سے شاخوں اور عضلات تنفس کے تشنج سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں تکلیف تنفس کی نوبت کے وقت ہوتی ہے اور وقفہ کی حالت میں مریض تندرست معلوم ہوتا ہے۔ کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ خشک اور مرطوب۔

خشک دمہ میں مرض ہوا کی نالیوں اور عضلات تنفس میں تشنج ہوتا ہے جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور مرطوب دمہ میں تشنج کے علاوہ نالیوں میں بلغم جمع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ خشک دمہ میں دورہ کی حالت اکثر دو چار گھنٹے تک رہتی ہے مگر مرطوب دمہ میں بہت دیر تک رہتی ہے۔ اس مرض کا دورہ کسی کو سال بھر میں ایک مرتبہ اور کسی کو مہینہ میں ایک مرتبہ اور کسی کو روزانہ ہوتا ہے۔

جب یہ بیماری تنہا ہو تو اسے سپاذ موڈک کہتے ہیں۔ امراض دماغ یا قلب یا معدہ۔ رحم یا پھیپھڑوں کے سبب سے ہو تو اس کو آرگنک کہتے ہیں یہ مرض کبھی موروثی ہوتا ہے اور کبھی سرد اور مرطوب ہوا لگنے یا گرد و غبار اور تیز چیزوں کے سونگھنے یا موسم کی تبدیلی سے بھی عارض ہو جاتا ہے اور کبھی دوسرے

اعضاء کی شرکت سے لاحق ہوتا ہے۔ (ماخوذ از مرج البحرین)

ہومیوپیتھی اور دمہ

تعریف اس مرض میں سانس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مشکل سے سانس لیا جاتا ہے اور یہ مرض نزلی ہوتا ہے۔ پھیپھڑے کے اوپر سیلز یعنی ہوائی نالیوں اور ٹیوبز میں تشنج ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے یہ تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ ہوائی کی نسبت بڑھاپے میں بہت کم ہوتا ہے۔

اسباب نزلہ۔ زکام۔ کھانسی وغیرہ کے بعد اکثر یہ مرض ہو جاتا ہے پھیپھڑوں۔ دل اور رحم کے امراض کی وجہ سے ہوتا ہے اور اکثر سورا کے جسم میں دبے رہنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔

علامات تکلیف کا دورہ دفعتاً شروع ہوتا ہے۔ رات کے دو تین بجے خروج ہوتا ہے۔ سینہ گھٹا ہوا ہوتا ہے۔ دم گھٹ گھٹ کر آتا ہے۔ اور سانس لینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ کھانسی سخت اٹھتی ہے۔ اور کھانستے کھانستے مریض کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ (ماخوذ از مخزن علاج ڈاکٹر نظام الدین۔ ایم بی ہومیو۔ ماہر تپ دق و امراض مزمنہ)

طب یونانی اور دمہ یا ربو

تعریف:۔ ربو یعنی دمہ کی بیماری اس طرح ہے کہ آدمی کو آرام سے بیٹھے

Scanned by CamScanner

ہوئے سانس نہ آئے۔ مگر جلد جلد پے در پے جیسے کوئی دوڑنے کے بعد اس کی سانس پھول جائے۔

اقسام اس کی تین اقسام ہیں (۱) ربو (۲) ضیق النفس اور (۳) ہیزیہ تینوں اقسام شیخ الرئیس نے بیان کی ہیں۔

اسباب جاننا چاہئے کہ قصر النفس کے بودہ اسباب ہیں (۱) سینہ کا پیدائشی طور پر تنگ ہونا جس سے سینہ یعنی پھیپھڑے پوری طرح پھیل نہ سکیں اور سانس تنگی سے آئے (۲) دوسری قسم وہ ہے کہ ریہ میں بلغم غلیظ آجائے جس سے سانس لینے میں رکاوٹ ہو (۳) ریہ (پھیپھڑے) اور سینہ قلب کے بخارات سے بھر جائیں اور وہ اخراج ان اعضا میں بند ہو جائیں اور ان اخراجوں کی کثرت سے ہوا کے راستے تنگ ہو جائیں اور سانس تنگی سے آئے (۴) ریہ پر سوئے مزاج گرم بالخراط غالب ہو ربو کا موجب ہو (۵) پسلیوں کے مضلات میں استرخا آجائے (۶) ریہ میں خشکی پیدا ہو جائے (۷) سرد ہوا ناک میں جانے سے اور سرد چیزوں کے کھانے اور سرد پانی پینے سے ریہ میں سردی بڑھ جائے (۸) سانس آنے کے راستوں میں بادغلیظ آجائے اور ہوا کے ناک میں لینے کو مانع ہو اور جاننا چاہئے کہ عروق خشنہ ہوا کی جگہ ہے۔ جس وقت اس میں کچھ بھی چیز پیدا ہو جاتی ہے ضرور سانس میں تنگی آتی ہے (۹) بہت سا مادہ سینے کی فضا میں گرے (۱۰) تیز بیماریوں میں جن کو حادہ کہتے ہیں بحران کے نزدیک ظاہر ہو (۱۱) ریہ میں یا دوسرے اعضاء میں جو اس کے نزدیک اور شریک ہیں ورم طارئ ہو جیسے حجاب حاجز میں، حجاب منصف میں اور حجاب مستبطن الاضلاع میں اور جگر و طحال میں ورم سے ہوتا ہے۔ جس سے انبساط کی حرکت کی جگہ تنگ ہو جاتی

ہے اور ربو پیدا ہو جاتا ہے (۱۲) نفسیاتی جذبات جن میں غصہ، غم، ندامت خوف اور لذت و مسرت شامل ہیں، ان کی شدت اس کا باعث ہو (۱۳) معدے کا امتلا انبساط کا مانع ہو اور اس سبب سے ربو ظاہر ہو جائے (۱۴) فتاق اس ربو کا باعث ہو۔ ماخوذ از طب اکبر

چونکہ دمہ کا تعلق پھیپھڑوں سے ہے اس لئے دمہ کی ماہیت و حقیقت سمجھنے کے لئے پھیپھڑوں کی بناوٹ اور انکے طبی اشغال سمجھنے ضروری ہیں،

پھیپھڑے

دل کے دونوں طرف دو پھیپھڑے سینے کے جوف میں جدا جدا قائم ہوتے ہیں اور ان پر دو جھلیاں ہوتی ہیں۔ ایک پھیپھڑے کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ غدی جھلی ہے۔ دوسری سفید رنگ کی اس کے ساتھ استر کرتی ہے اسے اعصابی جھلی کہتے ہیں۔ ان پردوں کے علاوہ پھیپھڑوں کا باقی جسم مضلاتی مادہ کا بنا ہوا ہے پھیپھڑوں کے اندر خون نسیم (آکسیجن) جذب کرنے کے لئے آتا ہے اور اپنے اندر سے کاربن جدا کر دیتا ہے۔ یہی خون قلب میں پہنچ کر قلب کی وساطت سے شریانوں کے ذریعے جسم کے خلیوں میں جذب ہونے کے لئے روانہ ہوتا ہے۔

پھیپھڑوں کے غیر طبعی افعال

جس وقت ان میں رطوبات و بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس وقت

Scanned by CamScanner

پھیپھڑوں کے اعصابی پردہ میں سوزش ہوتی ہے۔ اعصابی سوزش لوم کی زیادتی سے پھیپھڑوں میں تین قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔

ا۔ نظریہ مفرد اعضا کے اصول کے مطابق پھیپھڑوں کی اعصابی سوزش رجو پھیپھڑوں کے پردوں کی اعصابی تحریک سے ہوتی ہے، اسے پھیپھڑوں کے عضلاتی جزم میں سکون واقع ہو جاتا ہے۔ جس سے پھیپھڑوں کے جزم کی سستی کی وجہ سے پھیپھڑوں کی حرکات ضرورت سے کم ہو جاتی ہیں جس سے مریض کو سانس بار بار لینے کی حاجت ہوتی ہے۔

۲۔ پھیپھڑوں کے ضرورت سے کم حرکات کرنے سے جسم کی ضرورت کے مطابق آکسیجن کم جذب ہوتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے پھیپھڑوں کا بار بار حرکت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

۳۔ پھیپھڑوں کی نالیوں میں رقیق رطوبات کے جمع ہونے سے سانس کے ذریعے ہوا پوری مقدار میں نہیں جا سکتی جس سے ضرورت کے مطابق آکسیجن جذب کی جا سکے اور کاربن خارج کی جا سکے۔ اس طرح سانس لینے میں تنگی ہو جاتی ہے۔

جس وقت پھیپھڑوں کے جزم میں تحریک ہو کر ان میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھیپھڑوں اور قلب کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ جس سے پھیپھڑوں کے اندر کی رطوبات رطوبتِ خشک ہو جاتی ہے۔ پھیپھڑوں کے جزم میں تحریک اور انقباض سے مندرجہ ذیل تبدیلیاں آتی ہیں۔

ا۔ پھیپھڑوں کی تحریک سے فعلی طور پر کاربن ڈائی اوکسائڈ کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف آکسیجن کی پیدائش بند ہو جاتی ہے کیونکہ آکسیجن کا تعلق غدی تحریک سے ہے۔ کاربن ڈائی اوکسائڈ کا تعلق عضلاتی تحریک سے ہوتا ہے۔ نظریہ مفرد اعضاء میں عضلاتی تحریک سے غدی اعضاء میں سکون واقع

ہو جاتا ہے۔ چونکہ آکسیجن کی جسم میں بے انتہا کمی واقع ہو جاتی ہے اس لئے پھیپھڑے جو آکسیجن جذب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں شدید حرکات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

پھیپھڑوں کے شدید انقباض سے پھیپھڑوں میں تشنج شروع ہو جاتا ہے۔ جس سے ان میں انتصاب النفس کی صورت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی صورت کو تشنجی دمہ کہتے ہیں۔ اسی دمہ میں انسان کسی کروٹ آرام نہیں پاتا۔ نہ بیٹھنے سے چین آتا ہے نہ کھڑا ہونے سے اور نہ لیٹنے سے۔

پھیپھڑوں کے انقباض کے ساتھ ساتھ ان کی شریانوں میں بھی انقباض آجاتا ہے۔ جس سے پھیپھڑوں کے اندر خون پوری مقدار کے ساتھ صاف ہونے کے لئے نہیں آسکتا۔ جس سے جسم کے لئے ضرورت کے مطابق بدل ما تحلل حاصل نہیں ہوتا جس سے جسم میں بے حد نقاہت و کمزوری آجایا کرتی ہے۔

تیسری صورت پھیپھڑوں کے غیر طبعی افعال کی یہ ہے کہ اس میں پھیپھڑوں کے کبدی پردوں میں تحریک ہو کر ان کے جزم میں تقلیل ہو جاتی ہے۔ جس سے ان میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں ہو جایا کرتی ہیں۔

ا۔ پھیپھڑوں کے کبدی پردوں میں تحریک کا مطلب ان میں غدی تحریک کا پیدا ہونا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کریں کہ اگر پھیپھڑوں کے اعصابی پردوں میں تحریک سے ہائیڈروجن (تری) اور ان کے جزم میں تحریک سے کاربن (خشکی) کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کے غدی پردوں میں تحریک سے آکسیجن (حرارت) کی پیدائش ہوا کرتی ہے:

جونہی ان میں تحریک شدت اختیار کرتی ہے تو آکسیجن (حرارت) کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی زیادتی سے ایک دم پھیپھڑوں

Scanned by CamScanner

کے جرم یعنی عضلاتی حصہ میں تحلیل شروع ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھیپھڑے تحلیل کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں اور ضرورت کے مطابق حرکت نہیں کر سکتے جس سے ان میں سانس کی تنگی کی علامت پیدا ہو جاتی ہے۔

۲۔ چونکہ غدی تحریک سے آکسیجن (حرارت) کی زیادتی ہو چکی ہوتی ہے۔ جو گرمی خشکی کی صورت میں جسم میں جمع ہو رہی ہوتی ہے جس سے ان کے عضلات کی تحلیل شدہ رطوبات جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وظیفہ کے لئے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایلوپیتھی میں اس صورت کو ڈراپسی آف دی لنگز اور طب یونانی میں پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانا کہتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے طبعی وغیر طبعی افعال جاننے کے بعد ہمیں یہ بھی جاننا چاہئے کہ بلغم کیا ہے۔ اس کی اقسام کے لحاظ سے کون کون سی غیر طبعی صورتیں ہیں۔ کیونکہ ورم کی صورت میں یہی بلغم مختلف صورتیں اختیار کر چکا ہوتا ہے۔

بلغم

تعریف: بلغم طبعی وہ ہے جس کا خون بننا آسان ہو۔ (قرشی)

غیر طبعی بلغم جب یہی بلغم جس کا صالح خون بن سکتا ہے خون بننے سے بچ جائے تو اس فاضل بلغم کا جسم سے اخراج ضروری ہوتا ہے اگر یہ فوری طور پر جسم سے خارج ہو جائے تو انسانی جسم کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا ورنہ اس کے مزاج، مزے اور قوام میں بے شمار تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اطبائے قدیم نے مزے، مزاج اور قوام کے لحاظ سے

مندرجہ ذیل صورتیں تحقیق کی ہیں۔

مزے اور مزاج کے لحاظ سے بلغم کی غیر طبعی اقسام

۱۔ بلغم مسیخ (پھیکا بلغم) یہ بالکل سرد اور بہت ہی کچا ہوتا ہے۔
۲۔ بلغم حامض (کسیلا بلغم) یہ سردی اور خشکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔
۳۔ بلغم حامض مالح (نمکین بلغم) یہ بھی سردی خشکی کی طرف مائل ہوتا ہے (علامہ قرشی)
۴۔ بلغم ملح (نمکین بلغم) بلغم شور یہ گرمی خشکی کی طرف مائل ہوتا ہے (علامہ قرشی)
۵۔ بلغم حلو (بلغم شیریں) یہ گرم اور گرم تر ہوتا ہے (صاحب کامل والرسل)

قوام کے لحاظ سے بلغم کی غیر طبعی اقسام

۱۔ مائی (پانی جیسا بلغم) جو نہایت رقیق ہوتا ہے۔
۲۔ بلغم حصبی (کچ جیسا بلغم) جو نہایت غلیظ ہوتا ہے۔
۳۔ بلغم خام (کچا بلغم) یہ سفید جھاگ دار بلغم ہوتا ہے (قرشی)
۴۔ بلغم زجاجی جس کا قوام پگھلی ہوئی کانچ کی طرح لیسدار اور گاڑھا ہوتا ہے۔

نظریہ مفرد اعضا اور مندرجہ بالا غیر طبعی بلغم

۱۔ نظریہ مفرد اعضاء کے اصول کے تحت بلغم خام، بلغم مسیخ یا پھیکا بلغم، بلائی

انتہائی سرد تر ہوتا ہے۔ یہی بلغم پھیپھڑوں میں اعصابی دمہ پیدا کرتا ہے۔

۲۔ بلغم عفص اور بلغم حامض میں ترشی کی کمی بیشی کا فرق ہے۔ یہی بلغم اپنی انتہائی سردی خشکی سے پھیپھڑوں کی نالیوں میں اس قدر شدت کے ساتھ بستہ ہو جاتا ہے جس سے پھیپھڑوں کے عضلات میں تشنج شروع ہو جاتا ہے اور دم کشی واقع ہو جاتی ہے اور یہ بستہ بلغم اخراج پانے کا نام نہیں لیتا۔ اس سے پیدا ہونے والے دمہ کو عضلاتی دمہ یا تشنجی دمہ کہتے ہیں۔

۳۔ بلغم مالح (نمکین) اور بلغم حمضی (کچ جیسا بلغم) پھیپھڑوں کے غددی پردوں کی سوزش سے پیدا ہوتے ہیں اور مزاجاً گرم خشک ہوتے ہیں۔ یہی بلغم غدی دمہ کا باعث بنتے ہیں۔ چونکہ مزاجاً گرم خشک ہوتے ہیں۔ اس لئے جلد تحلیل ہو کر خارج ہونے کی استعداد رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غدی دمہ کا دورہ زیادہ دیر نہیں رہتا

ایلوپیتھی کی تحقیقات پر اعتراضات

میں نے وہ تمام تحقیقات من و عن درج کر دی ہیں جو مختلف طریقہ ہائے علاج لے کی ہیں۔ اب قارئین خود اندازہ لگا لیں کہ ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی نے طب یونانی اور نظریہ مفرد اعضاء کے مقابلہ میں کہاں تک اسباب دمہ پر تحقیقات کی ہے۔ قارئین کی معلومات میں اضافہ کے لئے ایلوپیتھی کی تحقیقات پر نظریہ مفرد اعضاء کے تحت جو جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں وہ ترتیب وار درج کرتا ہوں تاکہ ایک طرف دمہ کی حقیقت واضح ہو جائے۔ دوسری طرف وہ ناامیدی حکما کے ذہن سے اٹھ جائے کہ دمہ دم کے ساتھ جاتا ہے۔

۱۔ اول دمہ کی تعریف ہی غلط ہے۔ کیونکہ ہر دمہ عضلات تنفس کے تشنج سے پیدا نہیں ہوتا۔

یاد رکھیں کہ تشنج صرف عضلات یا حرکتی اعضاء میں ہوا کرتا ہے۔ اعصاب یا غدد میں تشنج واقع نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تشنجی دمہ کی ایک الگ قسم ہے جسے نظریہ مفرد اعضاء میں ہم عضلاتی دمہ کہتے ہیں۔

۲۔ دمہ کو ایک مرض کی صورت میں پیش کیا گیا ہے جو درست نہیں ہے۔ دمہ تو سانس کی تنگی کی ایک علامت ہے۔

۳۔ ایلوپیتھی میں دمہ کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں (۱) خشک دمہ (۲) تر دمہ۔ یہاں ایلوپیتھی پر دو قسم کے اعتراض پیدا ہوتے ہیں۔ اول دمہ دو قسم کا نہیں بلکہ تین قسم کا ہے۔ کیونکہ پھیپھڑے تین قسم کے فعلی اعضاء (اعصاب۔ غدد اور عضلات) سے بنتے ہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ایلوپیتھی گرمی، خشکی، تری اور سردی وغیرہ کو مدنظر رکھ کر نہ علاج کرتی ہے اور نہ ہی انہیں امراض کے اسباب میں تسلیم کرتی ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے خشک دمہ اور تر دمہ کیسے تسلیم کر لیا۔

۴۔ مرطوب دمہ میں تشنج کے علاوہ نالیوں میں بلغم کا جمع ہونا تسلیم کیا ہے۔ لیکن عملی طور پر ایلوپیتھی اخلاط (بلغم، صفراء اور سودا) کے وجود سے انکاری ہے۔ جب اس میں بلغم کی حقیقت ہی بیان نہیں کی جاتی تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے

۵۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مرطوب دمہ یا بلغمی دمہ تحقیق کرنے کے باوجود اس کا کوئی شافی علاج دریافت نہیں کیا جا سکا۔

۶۔ یہاں اور بھی کئی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن طوالت کے خوف سے نظر انداز کرتے ہوئے اس کی سب سے بڑی خامی کو واضح کرتا ہوں۔

Scanned by CamScanner

سو جاننا چاہئے کہ ایلوپیتھی نے پھیپھڑوں کے مفرد اعضاء کے ساتھ کسی بھی دمہ کا تعلق واضح نہیں کیا جو اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے جہاں اور جب بھی دمہ کو بیان کیا ہے۔ تمام پھیپھڑوں کو مرض میں مبتلا تسلیم کیا گیا ہے حالانکہ علم اناٹومی اور حقیقت اعضاء کے تحت پھیپھڑے تین قسم کے اعضائے بنے ہوئے ہیں جو اعصاب۔ غدد اور عضلات کہلاتے ہیں۔ یہی اعصاب، غدد اور عضلات ایک ہی وقت میں تحریک و تیزی اختیار نہیں کر لیتے بلکہ جب ان میں سے کسی ایک میں تحریک ہوتی ہے تو پھیپھڑوں کے دوسرے اعضاء میں تحلیل و تسکین ہوتی ہے۔ مثلاً اگر پھیپھڑوں کے اعصابی پردوں میں تحریک یا تیزی ہوگی تو ان کے غدد میں تحلیل اور عضلات میں سکون واقع ہوگا۔ اسی طرح اگر پھیپھڑوں کے عضلات میں تحریک یا تیزی ہوگی تو ان کے غدد اور اعصاب میں بالترتیب سکون اور تحلیل واقع ہو رہی ہوگی۔ (تحریک۔ تحلیل اور تسکین کی مکمل تشریح رہبر نظریہ مفرد اعضاء میں مطالعہ کریں)

۷۔ یہاں ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ فرنگی طب کو تمام امراض و علامات کے جراثیم تو مل گئے ہیں۔ لیکن دمہ کے جراثیم ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دمہ کے بیان میں جراثیم کا ذکر نہیں ہے۔

ہومیوپیتھی کی تحقیقات پر اعتراضات

۱۔ پہلا اعتراض تو وہی ہے جو ایلوپیتھی کی تعریف دمہ پر تھا کہ یہ مرض نہیں بلکہ سانس کی تنگی کی ایک علامت ہے۔

۲۔ دوسرا اعتراض بھی وہی ہے کہ دمہ کی ہر قسم میں ڈایافرام میں تشنج نہیں ہوا کرتا۔ کیونکہ دمہ بلغمی میں پھیپھڑوں کے عضلات میں استرخا کی صورت ہو چکی ہوتی ہے اور عدی دمہ میں پھیپھڑوں کے عضلات میں تحلیل ہو رہی ہوتی ہے۔ جس سے ضعف عضلات ہوتا ہے۔ صرف ایک صورت ہے کہ پھیپھڑوں کے جرم میں شدید تحریک ہو جائے اور ان میں تشنج ہونا شروع ہو جائے اور تشنجی دمہ کی علامات پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔

۳۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھ حضرات امراض کی حقیقت کو مانتے ہی نہیں۔ بلکہ اپنے علاج کو علاماتی علاج کہتے ہیں اور علامات کے مجموعے سے ہی علاج کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی یہاں انہیں دمہ مرض کی صورت میں کس طرح نظر آجاتا ہے۔

۴۔ یہاں یہ امر تسلیم کیا گیا ہے کہ اکثر سورا کے بدن میں دبے رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اس لازم کا ذکر نہیں کیا جو سورا کی غیر موجودگی میں تکلیف کا باعث بنتا رہا ہے۔

طب یونانی

طب یونانی نے دمہ کی تعریف میں اسے ایک بیماری تسلیم کیا ہے جو درست نہیں ہے۔

جہاں تک اسباب دمہ پر تحقیقات کا تعلق ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی تعریف کی جائے کم ہے۔ کیونکہ یہاں ہر اس سبب کو بیان کر دیا گیا ہے۔

Scanned by CamScanner

جس سے پھیپھڑوں کے افعال غیر طبعی ہو سکتے ہیں۔ جن میں مادی۔ کیفیاتی اور نفسیاتی تمام اسباب شامل ہیں۔

دمہ کو بالاعضاء تین اقسام میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ان کے مخصوص نام رکھ دیئے گئے ہیں تاکہ معالج غلطی سے بچ جائے اور مریض کو جلد از جلد صحت کے مقام پر پہنچا سکے۔

ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کی طرح نہیں کیا گیا کہ دمہ کی ہر قسم میں عضلات کے تشنج کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے چاہے دمہ استرخائی ہو' اور چاہے نزلی ہی کیوں نہ ہو۔

دوسرے اعضاء کی شرکت سے دمہ جیسی علامت پیدا ہونے کے اسباب کو کلی طور پر بیان کر دیا گیا ہے تاکہ دمہ کی صحیح اور یقینی تشخیص کر کے اس کا کامیاب علاج کیا جا سکے۔

دمہ کی مختلف اقسام کیوں ہیں

دمہ کی مختلف اقسام پھیپھڑوں کے مفرد اعضاء کی وجہ سے ہیں۔ جن اسباب سے مفرد اعضاء متاثر ہوتے ہیں انہی اسباب کے نام پر دمہ کے نام رکھ دیئے گئے ہیں۔ مثلاً جو دمہ نزلہ کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے اس کا نام نزلی دمہ رکھ دیا گیا ہے۔

اگر بلغم کی زیادتی کی وجہ سے تنگی تنفس ہو تو اسے بلغمی دمہ کہتے ہیں۔

اگر پھیپھڑوں میں ریح وغیرہ کے جمع ہو جانے سے سانس مشکل سے

آئے تو اسے ریحی دمہ کہا جاتا ہے۔

اگر پھیپھڑوں کے عضلاتی تشنج کی وجہ سے دم کشی کی صورت ہو تو اسے تشنجی دمہ کا نام دیا جاتا ہے۔

اگر دمہ جگر و گردوں کی سوزش کی وجہ سے ظاہر ہو تو اسے دمہ کلوی کہتے ہیں۔ اسی طرح لاتعداد دمہ کی اقسام بنا دی گئی ہیں۔

دمہ کو لاعلاج مرض کیوں سمجھا جاتا ہے

دمہ کو لاعلاج مرض سمجھنے کی واضح صورت تو یہی ہے کہ اس کا آج تک کوئی شافی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ علمی اور فنی طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ آج تک اس کی حقیقت و ماہیت کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ جو کچھ سمجھا گیا ہے وہ حقیقت سے کوسوں دور ہے۔

فرنگی طب کی گمراہی کی وجہ

بے شک فرنگی طب کو ناز ہے کہ اس نے تشریح الابدان (اناٹومی) اور منافع الاعضاء (فزیالوجی) میں بہت لمبی چوڑی تحقیقات کی ہیں ظاہر میں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تحقیق ضرور کرتی ہے مگر وہ غلط راستہ پر چلتی رہتی ہے۔ جیسے کعبہ کی طرف جانے والا ترکستان

Scanned by CamScanner

کے پرکشش راستہ کو اختیار کرلے۔ وہ چلتا ضرور گیا۔ مگر منزل مقصود سے بہت دور جا پڑا۔ پھر آنے والی نسلوں نے ترکستان کو ہی منزل مقصود قرار دے لیا یہی حال فرنگی کی تحقیقات دمہ اور اس کے علاج کا ہے۔

پھیپھڑوں کے نسوز (خلیہ دنیسج) کو تو فرداً فرداً علیحدہ کرکے دکھادیا۔ مگر جب ان کے غیر طبعی افعال کو سمجھا تو ان کے مفرد اعضاء کی بجائے تمام پھیپھڑوں کو مرض میں مبتلا سمجھا۔ یعنی مفرد اعضاء کی بجائے مرکب اعضاء کو سامنے رکھا اور جو کوئی تکلیف دہ علامت سامنے آئی۔ اسے روکنے کی کوشش کی گئی۔

مثلاً کسی مریض کو زکام ہوگیا۔ آنکھوں سے اور ناک سے پانی بہنے کی شکایت کی تو فوراً اسے بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ کسی نے کھانسی کی تکلیف بیان کی تو اسے روک دیا گیا۔ کسی نے درد اور بے چینی بتائی تو اسے مخدرات اور مسکنات وغیرہ سے بند کر دیا گیا۔ مگر ان علامات نے پیچھا نہ چھوڑا۔ بکرار بار اور جلد جلد ظاہر ہونے لگیں۔

افسوس انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تکلیف دہ علامات کن کن مفرد اعضاء کی پیدا کردہ ہیں۔ کن اعضاء میں سوزش ہے۔ کون سے مفرد اعضاء سست اور کمزور ہوگئے ہیں اور کن اعضاء میں تیزی اور کن اعضاء میں سستی پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اصل سبب کو تلاش کرکے مرض کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے۔

یہی صورت دمہ کی ہے۔ اس میں بھی وہی بے ڈھنگی چال اپنائی گئی ہے اور کسی اصول کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آج تک سوائے قدرات و مسکنات کے دمہ کے دورہ کو روکنے کا کوئی شافی علاج دریافت نہیں ہوسکا ہے۔

نظریہ مفرد اعضاء اور دمہ

اب میں یہاں نظریہ مفرد اعضاء کے تحت دمہ کی حقیقت و ماہیت اس کی اقسام اور پھر ان کی مختصر تشریح بیان کرتا ہوں۔ اس سے قارئین کو اندازہ ہو جائے گا کہ نظریہ مفرد اعضاء نے دمہ کے متعلق کیا کیا تحقیقات کی ہیں۔

تعریف دمہ دمہ کوئی مرض نہیں ہے بلکہ یہ سانس کی تنگی کی ایک علامت ہے جس سے سانس پھولتا ہے۔ یعنی مریض جلد جلد سانس لیتا ہے۔ یہ بالکل ایسی علامت ہے جیسے تیز دوڑنے، چلنے اور اوپر چڑھنے سے اکثر عارضی طور پر پیدا ہوتی ہے۔

اسباب دمہ کے اسباب داخلہ اور خارجہ تو پھیپھڑوں کے مفرد اعضاء ہی ہیں۔ جب تک ان میں سے کسی ایک میں تحریک، تحلیل اور تسکین پیدا نہیں ہوتی یہ علامت پیدا نہیں ہوتی یعنی پھیپھڑوں کے کسی نہ کسی مفرد عضو میں سوزش سے دمہ کی صورت ظاہر ہوا کرتی ہے۔ اور پھیپھڑوں میں سوزش کے اسباب کیفیاتی، لفیاتی اور مادی ہی ہوا کرتے ہیں۔

کیفیاتی اسباب میں سردی، گرمی، خشکی اور تری شامل ہیں اور ہر کیفیت اپنی ہی کیفیت والے مفرد عضو میں سوزش پیدا کرکے غیر طبعی علامات پیدا کردیتی ہے مثلاً سردی تری کی فضا ہو تو بلغم کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً تمام مخارج سے رطوبات کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ناک۔ آنکھ اور منہ سے پانی خارج ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کے اندر سکریشن ہو کر پھیپھڑوں کو بھی بھر دیتا ہے۔

اسی طرح سردی خشکی سے رطوبات بستہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ

Scanned by CamScanner

پھیپھڑوں میں پڑی ہوئی بلغمی رطوبات بستہ ہو کر اخراج پانے کا نام نہیں
یہی صورتیں نمونیا اور عضلاتی دمہ کا باعث ہوتی ہیں۔

مادی اسباب میں اغذیہ، ادویہ اور اشیاء سب شامل ہیں بلکہ
میں گیسیں (ہائیڈروجن۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن) پائی جاتی ہیں
کی کمی بیشی بھی پھیپھڑوں کے غیر طبعی افعال کا سبب بنتی ہے۔

یعنی کبھی پھیپھڑوں میں ہائیڈروجن جو پانی کا درجہ رکھتی ہے زیادہ
جاتی ہے۔ جس سے ایک طرف آکسیجن گیس (نسیم) جسم سے خارج ہوتی
دوسری طرف جسم کے ایندھن، دخان، کاربن ڈائی آکسائیڈ کی پیدائش بنظر
جاتی ہے۔ نتیجہ اس کا دم کشی ہوتا ہے۔

کبھی کاربانک ایسڈ گیس کی زیادتی ہو کر ہائیڈروجن (رطوبات) تحلیل
جاتی ہیں۔ اور آکسیجن یعنی نسیم کی پیدائش (جو کاربانک ایسڈ گیس کو جلانے کا
دیتی ہے) بند ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کبھی آکسیجن (نسیم) کی زیادتی
تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔

نفسیاتی اسباب میں غم، غصہ، ندامت و خوف، لذت و مسرت
نفسیاتی جذبات کی زیادتی باعث تکلیف ہو جاتی ہے۔

غم و رنج کی وجہ سے جب انسان روتا ہے تو عام آدمی کے مشا
کی بات ہے کس طرح آنکھوں، ناک اور منہ سے پانی کا اخراج ہوتا
جو اندرونی طور پر پھیپھڑوں پر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ
اکثر دمہ کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے جذبات
بھی پھیپھڑوں میں رطوبات کی کمی بیشی ہو جایا کرتی ہے۔ جس کے با
دمہ کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

دمہ اور اس کے اسباب

دمہ کا تعارف اور دمہ کی علامات تو سابقہ ایڈیشن میں شرح بسط سے پیش کر
تھیں لیکن اسباب میں دو بڑے اسباب کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ علاج میں
بنظر رکھ کر غذا دوا تجویز کی جا سکے۔

آلات انہضام کے مفرد اعضا کی کمزوری

دمہ بلغمی ہو یا صفراوی یا سوداوی جب کسی مریض کو ہو جاتا ہے، تو
سب سے پہلے معدہ کے مفرد اعضا میں تیزی یا سستی پیدا ہو جاتی ہے جس سے
مریض خصوصیت کے ساتھ مخصوص قسم کی اغذیہ زیادہ کھاتا ہے۔ اور اس کے مقابل
اغذیہ بہت کم کر دیتا ہے۔

مثلاً دمہ بلغمی کے مریض دودھ، گھی، چاول، دلیا، مٹھائیوں میں جلیبیاں
کھوا، حلوہ گاجر، سبزیوں میں بھنڈی، شلغم، سونگرے، کدو، توری، ٹینڈے،
پیٹھا وغیرہ۔ جوس میں گنے کا رس یا گاجر کا جوس وغیرہ اکثر پیتا ہے۔ اس کے
مقابلہ میں ترش پھل کینوں، جامن، لیموں، اچار، ٹماٹر، گوشت، بینگن، رائی، دہی،
لسی وغیرہ کو نہ صرف کھانا بند کر دیتا ہے بلکہ ان سے ڈرتا ہے۔ اگر کوئی انہیں
پیش کرے تو یہ کہہ کر واپس کر دیتا ہے کہ یہ چیزیں تو مجھے موافق نہیں۔ یہ تو

حکیم علی ضیاء

Scanned by CamScanner

مجھے نقصان دیتی ہیں لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بھائی صاحب آپ یہ چیزیں جن سے آپ کو نقصان ہوتا ہے کھاتے ہی نہیں تو پھر آپ اتنے بیمار کیوں ہیں۔

ایسے مریضوں سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ نے مدت سے یہ چیزیں اس لئے چھوڑ رکھی ہیں کہ آپکو یہ نقصان دیتی ہیں اور جو اغذیہ کھاتے ہیں ان سے بیماری بڑھ تو رہی ہے لیکن کم نہیں ہو رہی لہذا میرے کہنے پر اس خیال سے یہ چھوڑی ہوئی اغذیہ بے خوف خطر کھانی شروع کر دیں تاکہ ان سے ہی شفا حاصل ہو جائے یقین جانیے جو مریض پہلی اغذیہ چھوڑ کر ان کو باقاعدہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، انہیں اول تو دوبارہ دمہ کا دورہ نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے۔ تو بہت ہی کم۔

اکثر مریضوں کو اگر بلغمی دمہ کا دورہ آٹھ دس دن متواتر رہا کرتا ہے۔ ان اغذیہ کے کھانے سے دو تین دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے

بالکل اسی طرح خشک دمہ جو سوداوی دمہ بھی کہلاتا ہے جس میں بلغم کا نام نشان نہیں ہوتا پھیپھڑوں میں شدید تشنج ہوتا ہے اختلاج قلب گھبراہٹ بے چینی اور دم کشی اتنی شدید ہوتی ہے کہ اکثر مریض تو اٹھ اٹھ کر سانس لیتے ہیں گھر والوں اور تیمارداروں سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی

ایسے مریض مرچ مصالحہ چٹ پٹی اور مرغن سبزیاں، گوشت، ٹماٹر، اچار، انڈے، مچھلی وغیرہ وغیرہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں انہیں لاکھ پرہیز بتائیں۔ پرواہ نہیں کرتے۔

اگر غذا دوا سے کچھ آرام آگیا تو فوراً انہیں پھر کثرت سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جن سے ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ مریض کو پھر پہلے سے بھی زیادہ شدت سے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔

میرا ایک دوست جو خود حکیم بھی ہے۔ دم کشی کا مریض ہے۔ وہ تیتر بٹیر اور کبوتر وغیرہ شکار کرتا ہے۔ اور خوب کھاتا ہے۔ اگر کبھی شکار میسر نہ آئے تو بازار سے گوشت خرید کر ضرور کھاتا ہے۔ اسے کئی بار گوشت سے منع کیا ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن گوشت نہیں چھوڑ سکتا۔

یہ کیفیت تو میں نے ایک معالج کی بیان کی ہے عام مریضوں کی عادات اس سے بھی سخت ہوں گی۔

علی ہذا القیاس اس قسم کی عادت غدی دمہ کے مریضوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ وہ بھی مخصوص قسم کی غدی غذائیں اتنی کثرت سے کھاتے ہیں کہ ان کے معدہ امعاء کے غدد دفشا مخاطی کا فعل تیز ہو جاتا ہے۔ اور ان کے قابو میں معدہ امعاء کے اعصاب میں سستی اور سکون ہو جاتا ہے۔

مندرجہ بالا سطور سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ دمہ بلغمی ہو یا سوداوی یا صفراوی۔ ہر ایک اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک مریض کے معدہ امعاء کے مفرد اعضا بالترتیب اعصاب، عضلات و غدد فعل میں تیز اور تحریک میں نہیں آجاتے۔ اور ان میں سوزش پیدا نہیں ہو جاتی۔

یادداشت یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب ایک ہی قسم و مزاج کی اغذیہ

Scanned by CamScanner

کیفیت سے کھائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے معدہ امعاء کے وہ مفرد اعضاء تحریک و تیزی اور تحریک میں آجاتے ہیں۔ جن کے مزاج کی غذا مریض زیادہ سے زیادہ کھاتا ہے۔

جب معدہ کے مخصوص مفرد اعضا تحریک و تیزی میں آجاتے ہیں تو وہ کھائی ہوئی غذا سے اپنے مزاج کی خلط زیادہ بناتے ہیں۔ اور اس کے مقابلہ کی دوسری اخلاط کم کیونکہ دوسرے مزاج کی غذا ہی مریض کم کھاتا ہے۔

جب کوئی مریض ایک ہی مزاج کی اغذیہ مسلسل کھاتا رہتا ہے۔ اور تو اس کے جوس سے ایک ہی قسم کی خلط بنتی رہتی ہے اور وہ جب ضرورت سے زیادہ جسم و خون میں جمع ہو جاتی ہے۔ تو جسم انسان کے لئے ایک بوجھ بن جاتی ہے

خداوند تعالیٰ نے جسم انسان میں جہاں جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لئے بھوک پیاس کی تحریک ودیعت کر دی ہے۔ وہاں اگر جسم میں ضرورت سے زیادہ کوئی خلط یا مادہ جمع ہو جائے تو اسے اعتدال پر رکھنے کے لئے فاضل مادہ کو خارج از بدن کرنے کے لئے مختلف مقامات بنا دیئے ہیں۔ جن سے فاضل مادہ ضرورت کے مطابق نکلتا رہتا ہے۔

مثلاً آنکھ، ناک، کان، منہ، پھیپھڑے، پستان، گردے، مثانہ احلیل (پیشاب کی نالی رحم) مقعد وغیرہ۔

اب جب کہ معدہ امعاء کے جو مفرد اعضا تحریک میں آجاتے ہیں۔ وہ اپنے مزاج کی غذا زیادہ سے زیادہ طلب کرتے رہتے ہیں جس سے وہ خلط

کی صورت میں جمع ہوتے ہوتے ضرورت سے زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہے

اب طبعیت کے لئے وہ ضرورت کی بجائے نقصان کا سبب بن جاتی ہے لہذا طبعیت مدبرہ بدن اسے مخارج سے خارج کرنا شروع کر دیتی ہے بدقسمتی سے کوئی نہ کوئی مخرج ضرورت کے مطابق فضلات کا اخراج نہیں کرتا۔ مثلاً بعض مخارج بعض مخصوص موسموں میں زیادہ فضلات کا اخراج کرتے ہیں اور بعض موقعوں پر تقریباً نہ ہونے کے برابر مثلاً جلد میں گرمیوں کے موسم میں پتلے فضلات براہ پسینہ خارج ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن سردیوں میں بہت ہی کم۔ یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں خارش دھدر چنبل زیادہ تنگ کرتی ہیں یہاں یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر جلد کسی موسم میں کام کم کر دیتی ہے تو اس کے فضلات جسم میں پڑے نہیں رہ جاتے بلکہ گردوں اور مثانہ کو گرمیوں کی نسبت جلد کا بچا ہوا مواد زیادہ خارج کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں پیشاب گرمیوں کی نسبت زیادہ آیا کرتا ہے

لیکن اگر بدقسمتی سے امعاء گردے اور مثانہ بھی کام پورا نہ کریں تو گلا، ناک، آنکھ اور پھیپھڑوں کی طرف مواد و فضلات چلے جاتے ہیں جن سے ان کے افعال کم و بیش ہو جاتے ہیں۔

یعنی ان میں تحریک و تیزی ہو کر سوزش ہو جاتی ہے جس سے فضلات کی سکریشن شروع ہو جاتی ہے جسے ہم زکام، نزلہ، وغیرہ ناموں سے پکارتے ہیں۔

اگر ناک آنکھ اور گلا سے فضلات نزلہ، زکام اور رشیہ و رطوبت کی

Scanned by CamScanner